

21. RIASSUNTO DELLA STRUTTURAZIONE VASCOLARE TRAMITE LA CAVITÀ AMNIOTICA

DURATA : 05:54

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità la strutturazione vascolare attraverso la cavità amniotica, evidenziandone l'integrazione con il sistema vitellino e il suo ruolo nello sviluppo embrionale. I concetti chiave trattati includono il movimento di riassorbimento verso il centro dell'embrione, l'integrazione arteriosa e l'importanza della cavità amniotica nella ridefinizione degli spazi interni. Vengono discussi i movimenti essenziali come la cefalizzazione, l'arrotolamento embrionale e il rientro dei fluidi, sottolineando l'impatto del sistema notocordale e del tubo neurale. Questa conoscenza è cruciale per i professionisti che cercano di riconoscere le dinamiche interne che influenzano la salute embrionale e il benessere generale.

RIASSUNTO DELLA STRUTTURAZIONE VASCOLARE TRAMITE LA CAVITÀ AMNIOTICA

L'ORIGINE E L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Il **sistema vascolare**, alla sua periferia, è fortemente integrato nel **sistema vitellino**. La **cavità amniotica**, inizialmente della stessa dimensione della vescicola vitellina, gioca un ruolo fondamentale.

L'embrione si allunga e cresce considerevolmente. L'importanza di questa cavità amniotica risiede nella sua capacità di integrare completamente il sistema vitellino. Questo movimento è cruciale e costituisce il punto centrale del nostro studio.

IL MOVIMENTO DI RIASSORBIMENTO E LA ZONA B

In questo movimento, tutto il sistema vitellino si riassorbe verso il centro dell'embrione, reintegrando l'insieme. Questa cavità amniotica, che possiamo definire come la **zona B**, in relazione al sistema aortico, aspira tutto verso il centro.

Questo processo si svolge sia su un piano **trasversale addominale** che **toracico**.

Con la crescita e l'instaurazione del cuore, così come l'importante sviluppo del cervello, la cavità amniotica prende il sopravvento. Essa ingloba completamente tutto lo spazio del **celoma esterno**. Solo una parte di questo celoma interno sarà integrata in un celoma interno. Più la cavità amniotica cresce, più il sistema si integra.

L'INTEGRAZIONE ARTERIOSA E L'AVVOLGIMENTO EMBRIONALE

Due elementi chiave riassumono l'integrazione del sistema arterioso, dalla periferia verso il centro: la **cefalizzazione** e l'**avvolgimento embrionale**. Ciò include la cardializzazione, la diaframmatizzazione e l'epatizzazione.

La cavità amniotica agisce come un movimento di integrazione, ridefinendo gli spazi. In questa dinamica, sia orizzontalmente che verticalmente, si costruisce la zona B. La vescicola vitellina, contenente l'informazione primitiva a livello venoso, interagisce con l'esterno per reintegrare il corpo e il sistema venoso.

IL RUOLO DEI FLUIDI E DELLA VESCICOLA VITELLINA

Il segreto risiede nel **rimpatrio dei fluidi** verso il centro, con il sistema fasciale che gioca un ruolo preponderante in questa liberazione.

La vescicola vitellina è una grande fonte di informazione. Il movimento di integrazione comprende:

- La trasformazione del celoma esterno in un celoma interno.
- La chiusura del tubo neurale.
- L'integrazione e il movimento verso il centro.
- La costruzione, orchestrata dalla cavità.

RESTITUIRE LA CAVITÀ E LA ZONA B

L'obiettivo è restituire questa cavità e la zona B per reintegrare la circolazione interna.

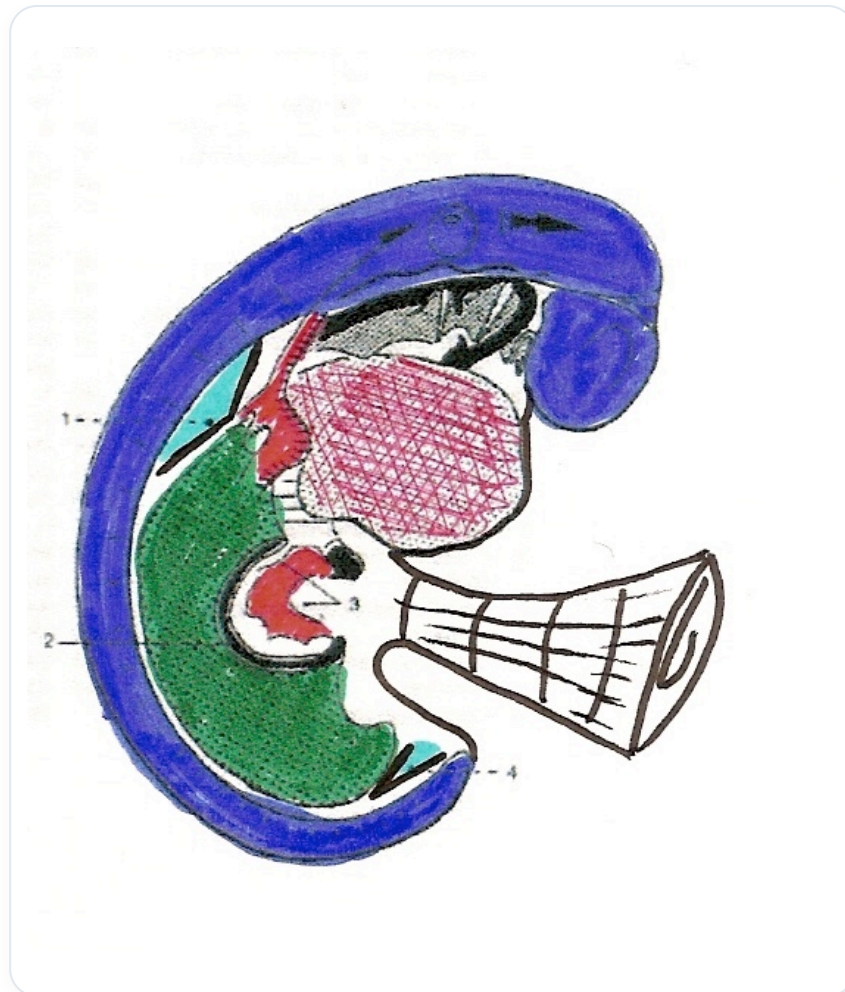


FIG. — Questa immagine sembra essere una visione d'insieme, quindi inserirla dopo una frase di contestualizzazione generale sulla reintegrazione del sistema circolatorio appare appropriato

Visualizzando lo schema come una persona sdraiata:

- In blu, l'integrazione in un tubo neurale.
- Il resto forma la pelle, uno strato **ectodermico**.

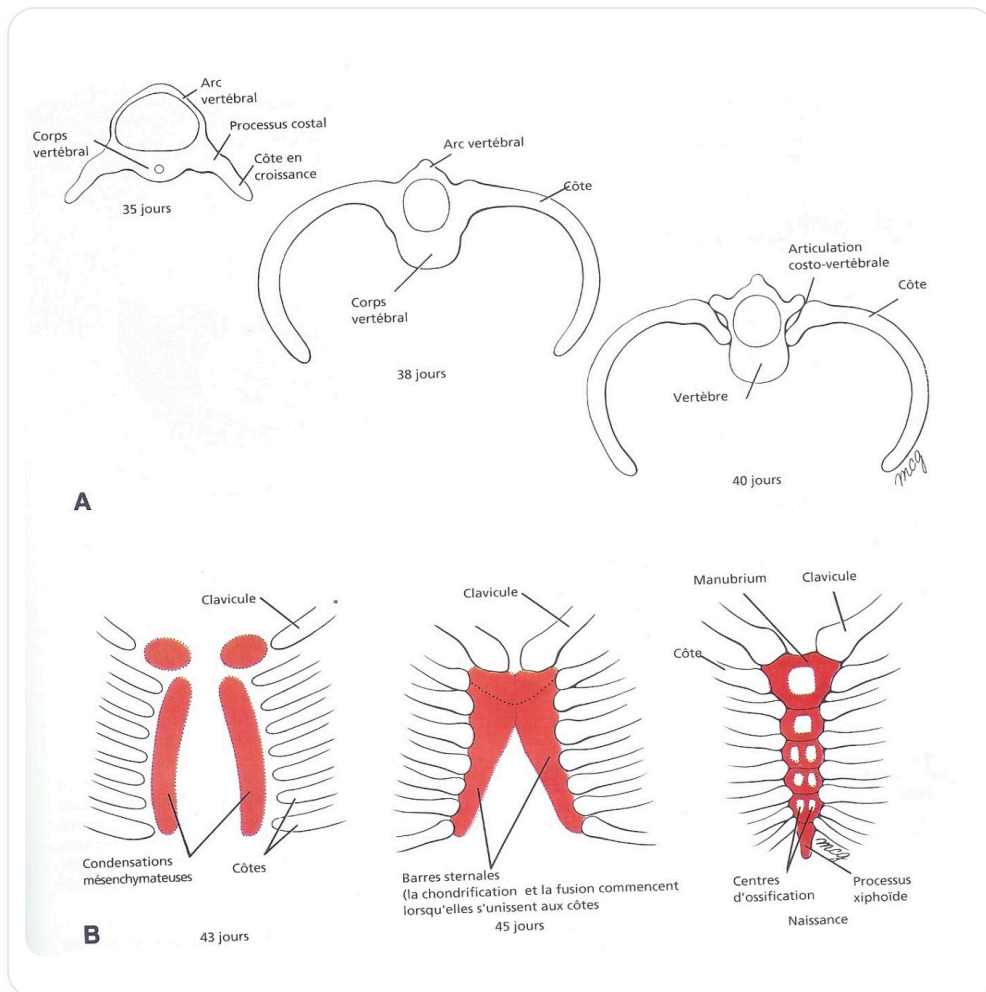


FIG. — L'immagine sembra dettagliare l'integrazione del sistema nervoso o un aspetto della strutturazione embrionale

Simultaneamente, l'integrazione della vescicola vitellina contribuisce a formare una parte del sistema digestivo, mentre tutto il sistema venoso si integra. Il movimento da seguire è quello della cavità amniotica che cresce, portando a una fusione per formare la parte longitudinale, il tubo digestivo.

L'integrazione del celoma esterno in un futuro celoma interno è visualizzata in giallo, dove tutto si ricongiunge sulla linea mediana.

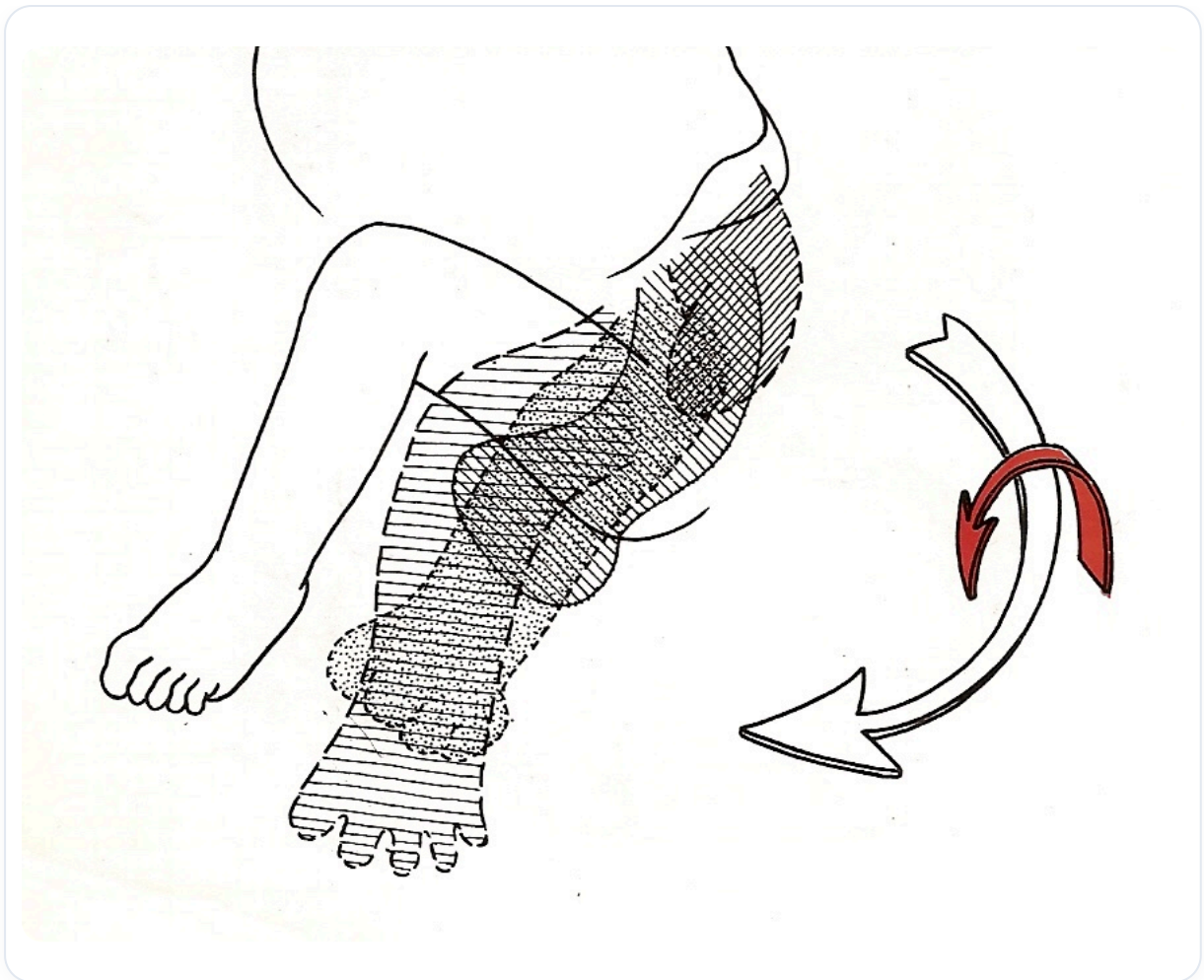


FIG. — Probabilmente una fase della formazione del tubo digerente o una struttura longitudinale

IL GRANDE MOTORE: SISTEMA NOTOCORDALE E TUBO NEURALE

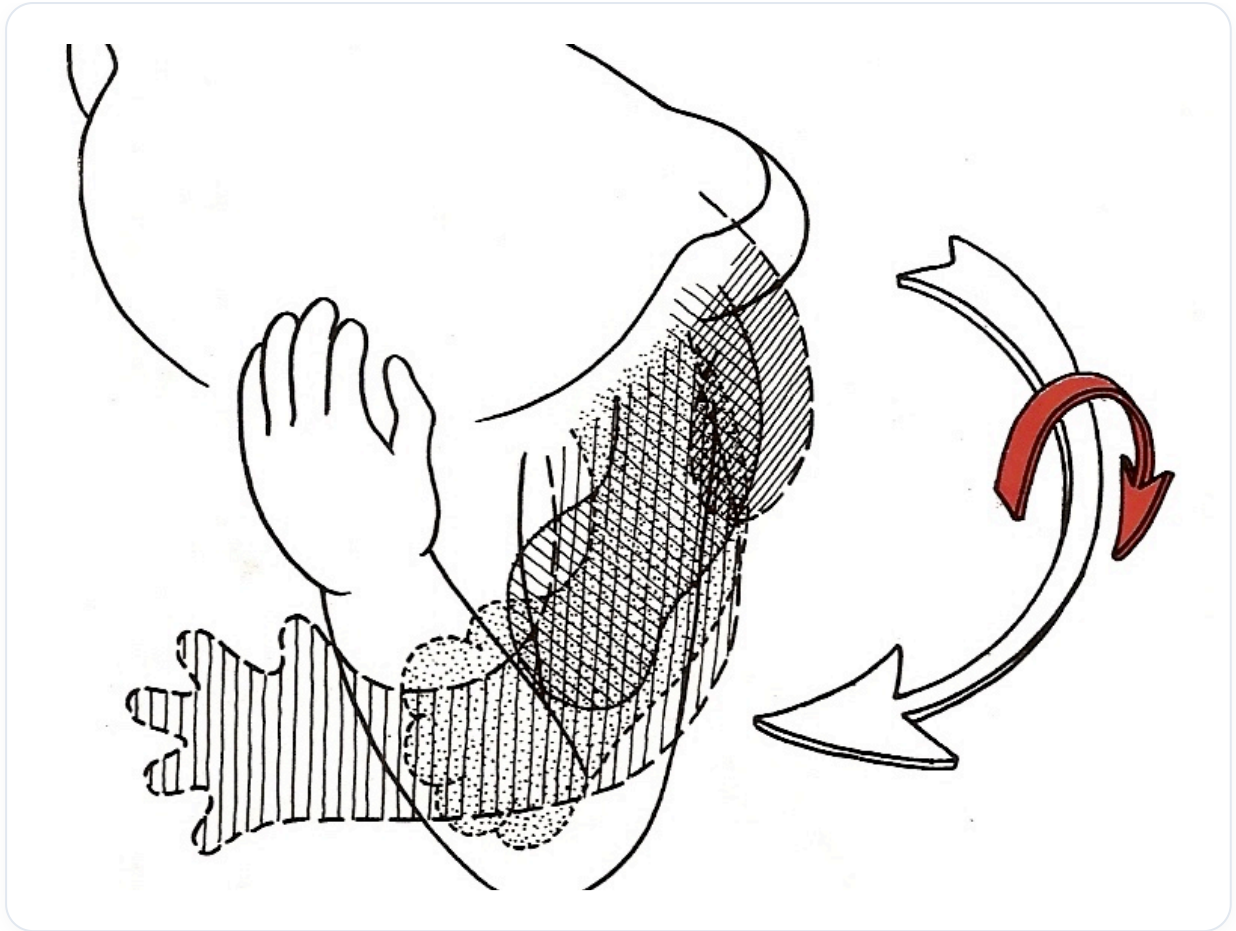


FIG. — Probabilmente la convergenza delle strutture verso la linea mediana, coerente con la frase

Il motore principale di questo processo è il **sistema notocordale**, che influenza il tubo neurale e organizza il sistema vascolare primitivo aortico. Esso reindirizza l'informazione con l'integrazione progressiva di tutto il sistema trasversale, dalla periferia verso il centro.

Seguiremo questo movimento passo dopo passo. È essenziale "lasciar fare" la respirazione primaria.

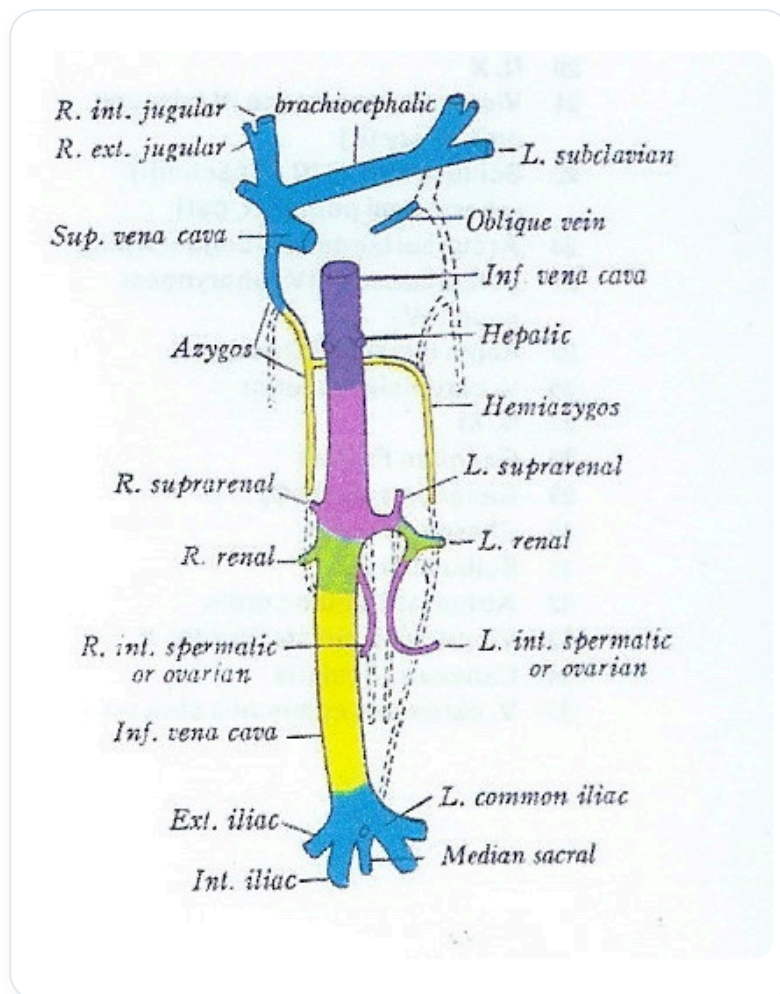


FIG. — Sistema notocordale o una vista trasversale dell'integrazione, corrispondente al testo

MOVIMENTO ENDOVOLONTARIO DEI POLMONI E CONSAPEVOLEZZA DEL PEDUNCOLO OMBELICALE

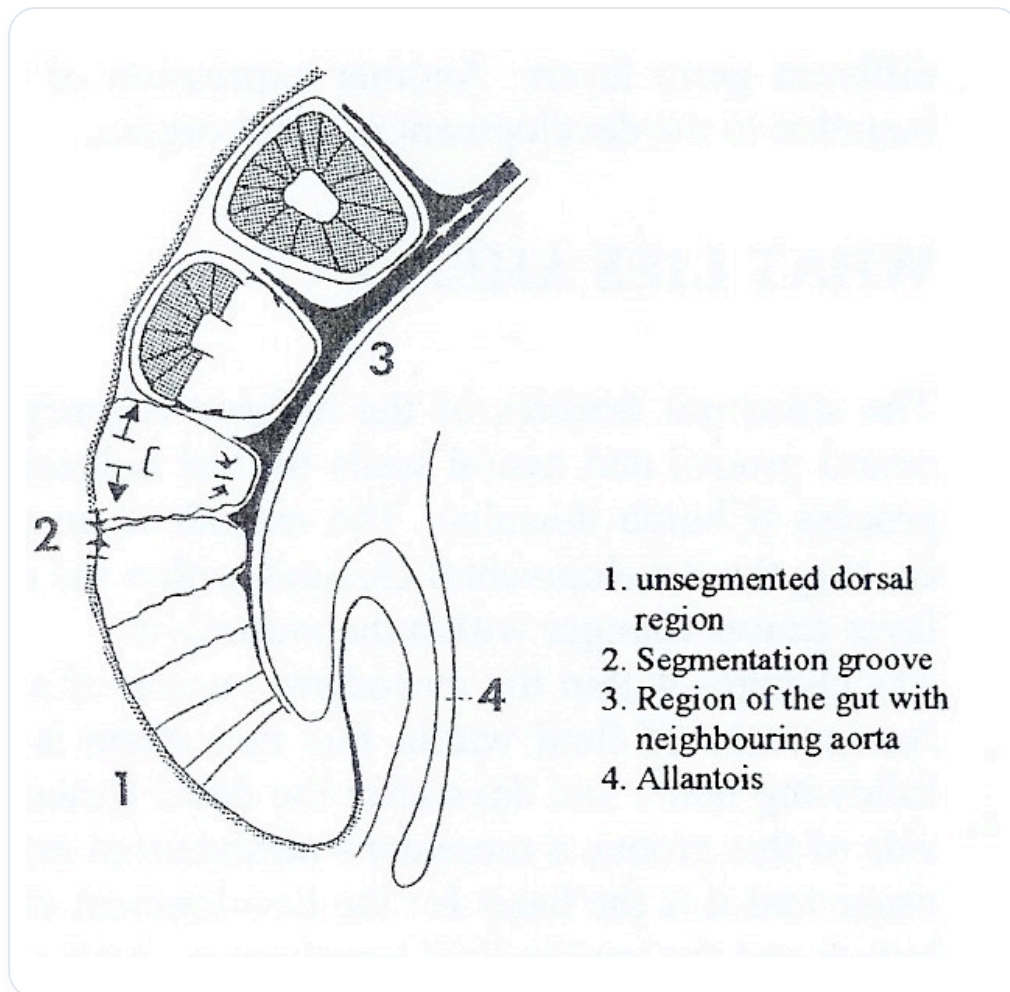


FIG. — L'immagine presenta la struttura venosa viscerale menzionata nel riassunto, e questa frase segna una transizione verso la nozione di 'movimento'

Il **movimento endovolontario dei polmoni** parte dall'endoderma ed è orientato dal sistema vascolare. La consapevolezza del **peduncolo ombelicale** deve tornare in questo spazio, permettendo di percepire la forza della cavità amniotica che cresce, integrando al contempo i processi di cefalizzazione, cardializzazione, diaframmatizzazione ed epatizzazione.

Il ritorno avviene quindi. La vescicola vitellina, spinta dalla velocità di crescita differenziale, sarà ripresa nello schema. Essa spingerà il peduncolo per ricongiungersi alla vescicola vitellina e formare più tardi il cordone ombelicale.

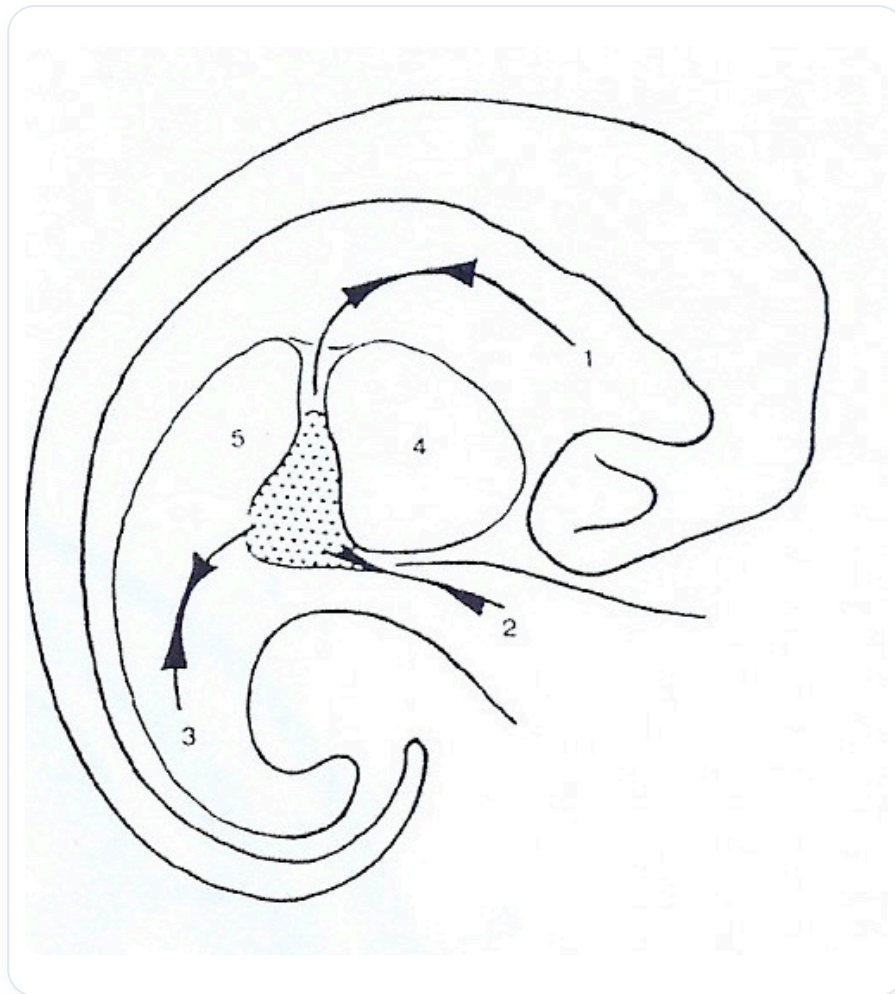


FIG. — L'immagine corrisponde alla descrizione dell'integrazione dei sistemi come quello vitellino ed epatico

Tutto si ricongiunge qui, partendo da un peduncolo per tornare a un cordone.

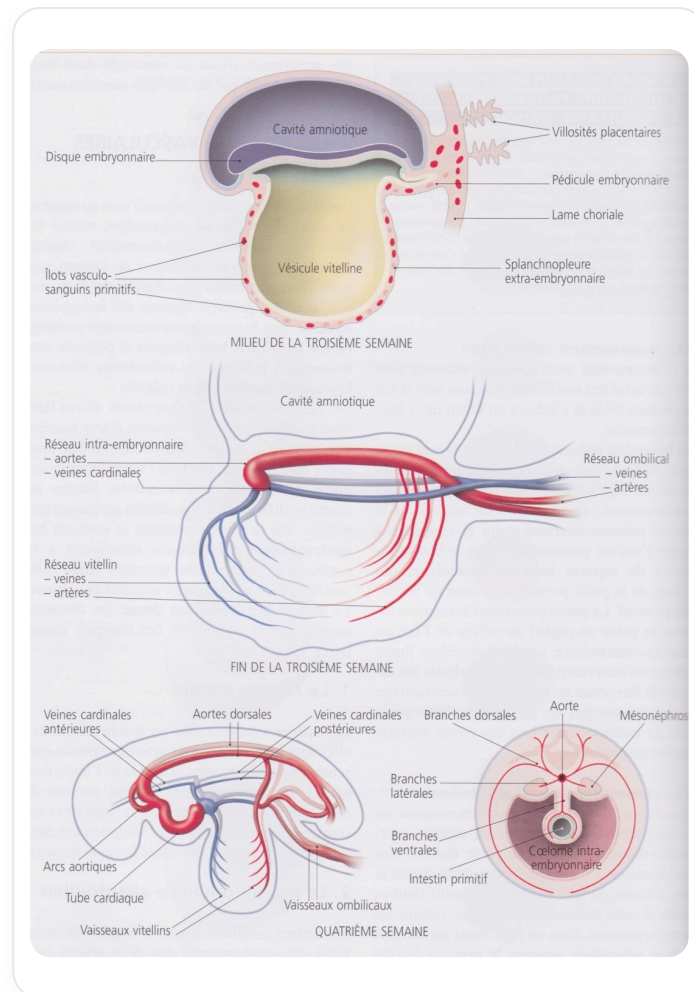


FIG. — *Regression della vescicola vitellina e formazione del cordone ombelicale, il che è logico dopo la menzione del 'ritorno'*

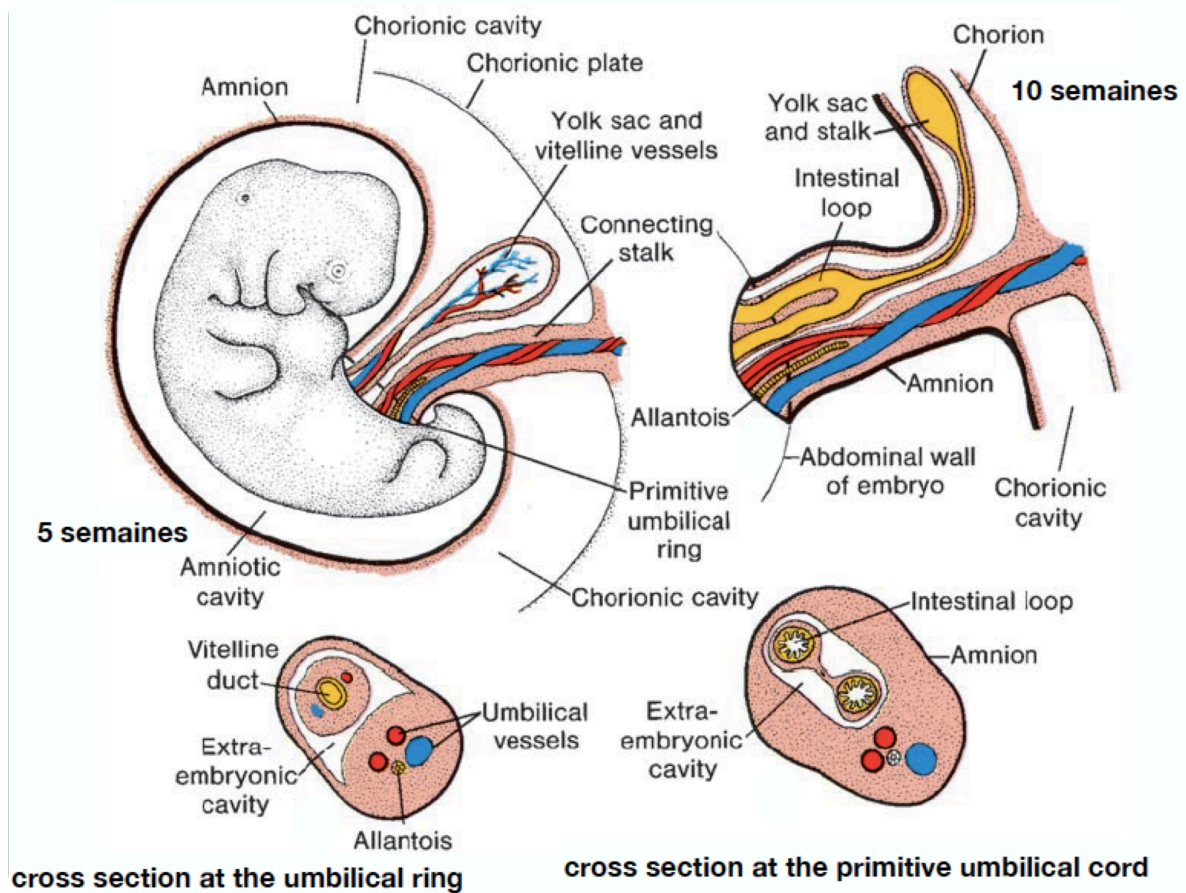


FIG. — *Formazione del cordone ombelicale*

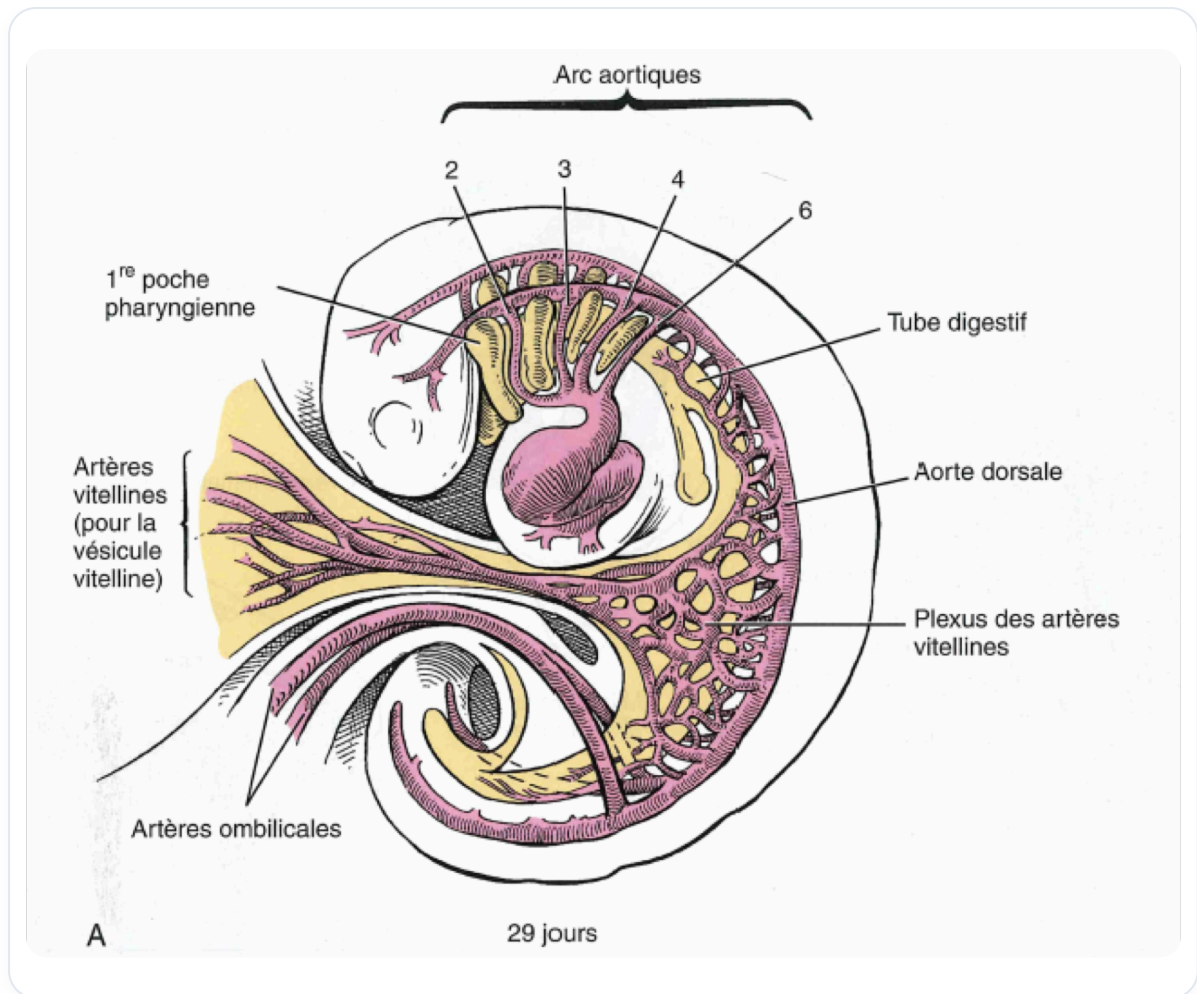


FIG. — Questa immagine sembra essere una vista riassuntiva o una visualizzazione finale dell'integrazione del sistema vitellino e dei suoi residui, coerente con la fine del paragrafo

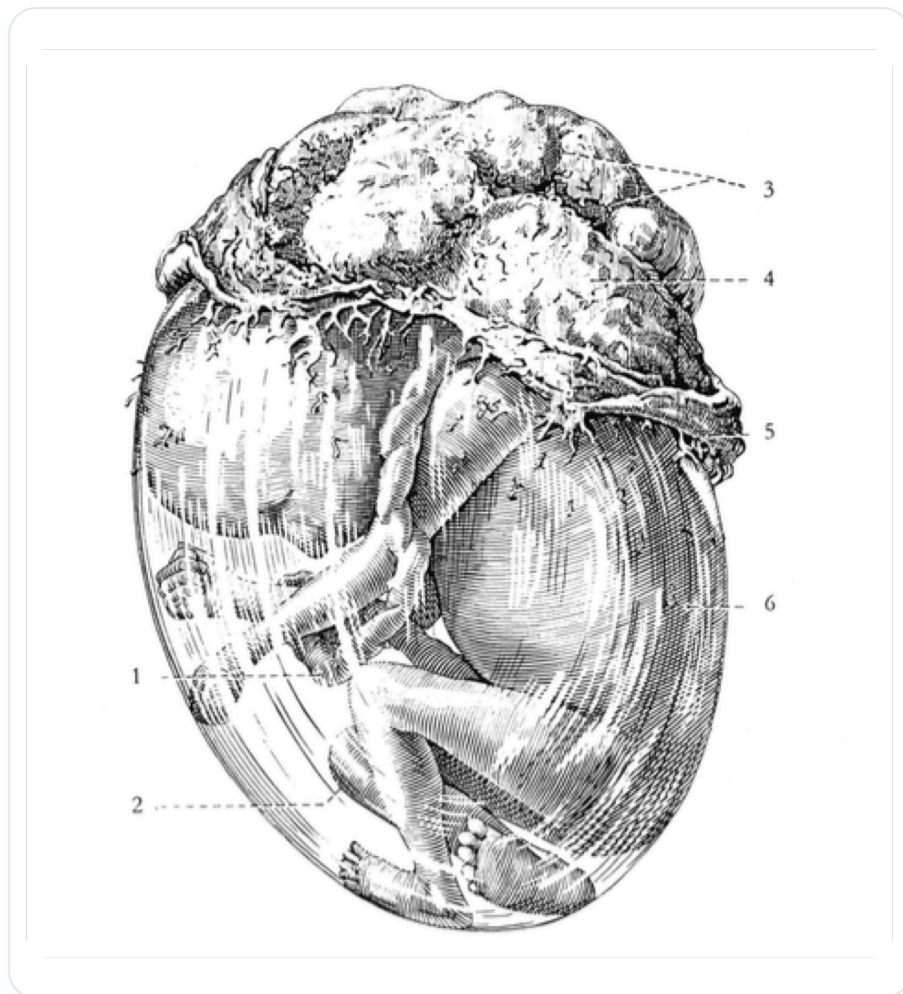


FIG. — Feto nell'utero